

PUNTO ENARM

Preguntas Medicina Interna

242 preguntas · 13/09/2026 · La Mole (Los 4 Fantásticos)

N355 (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACALASIA? MANOMETRÍA ESOFÁGICA CON FALTA DE RELAJACIÓN DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR Y APERISTALSIS

N358 (Wed Feb 18): ¿CÓMO SE DEFINE LA ACALASIA? TRASTORNO DE LA MOTILIDAD ESOFÁGICA CARACTERIZADO POR DEFICIENTE RELAJACIÓN DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR Y PÉRDIDA DE PERISTALSIS ESOFÁGICA

N361 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES LA SEGUNDA ELECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA ACALASIA? DILATACIÓN NEUMÁTICA CON BALÓN DE 30-40 MM

N363 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO? MANOMETRÍA ESOFÁGICA

N364 (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA EL DIAGNÓSTICO DE ERGE? PHMETRÍA CON IMPEDANCIA EN 24 HORAS

N366 (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL COMPLICACIÓN DE LA ESOFAGITIS? ÚLCERA ESOFÁGICA

N431 (Wed Mar 04): LA ETIOLOGIA MAS FRECUENTE DE ARTRITIS SEPTICA ES STAPHYLOCOCCUS AUREUS

N434 (Wed Mar 04): LA OSTEOMIELITIS ES UNA INFECCION DEL HUESO QUE AFECTA CAVIDAD MEDULAR, PERIOSTIO Y TEJIDO OSEO

N439 (Thu Mar 05): EL DOLOR LUMBAR INFLAMATORIO MEJORA CON EL EJERCICIO Y EMPEORA CON EL REPOSO

N441 (Thu Mar 05): LA LUMBALGIA SE CLASIFICA EN AGUDA (<6 SEMANAS), SUBAGUDA (6-12 SEMANAS) Y CRONICA (>12 SEMANAS)

N444 (Thu Mar 05): LA NEUROPATIA POR COMPRESION MAS FRECUENTE ES EL SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO

N454 (Mon Mar 09): LA TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO SE CONFIRMA CON RADIOGRAFIA

N461 (Tue Mar 10): LA OSTEOARTRITIS ES LA ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA MAS FRECUENTE

N462 (Tue Mar 10): LAS ARTICULACIONES MAS AFECTADAS EN OSTEOARTRITIS SON RODILLA, CADERA, MANOS Y COLUMNA

N463 (Tue Mar 10): EL DOLOR EN OSTEOARTRITIS EMPEORA CON LA ACTIVIDAD Y MEJORA CON EL REPOSO

N464 (Tue Mar 10): LOS NODULOS DE HEBERDEN AFECTAN LAS ARTICULACIONES INTERFALANGICAS DISTALES

N465 (Tue Mar 10): LOS NODULOS DE BOUCHARD AFECTAN LAS ARTICULACIONES INTERFALANGICAS PROXIMALES

N466 (Wed Mar 11): EL GOLD STANDARD PARA DIAGNOSTICO DE OSTEOARTRITIS ES RADIOGRAFIA SIMPLE

N467 (Wed Mar 11): EL TRATAMIENTO INICIAL DE OSTEOARTRITIS ES PERDIDA DE PESO, EJERCICIO Y ANALGESICOS

N468 (Wed Mar 11): EL FARMACO DE PRIMERA LINEA EN OSTEOARTRITIS ES PARACETAMOL

N469 (Wed Mar 11): LA ARTRITIS REUMATOIDE ES UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE SISTEMICA

N470 (Wed Mar 11): LAS ARTICULACIONES MAS AFECTADAS EN ARTRITIS REUMATOIDE SON METACARPOFALANGICAS Y PROXIMALES

N471 (Thu Mar 12): EL FACTOR REUMATOIDE Y LOS ANTICUERPOS ANTI-CCP SON MARCADORES DE ARTRITIS REUMATOIDE

N472 (Thu Mar 12): EL FARMACO MODIFICADOR DE LA ENFERMEDAD DE PRIMERA LINEA EN ARTRITIS REUMATOIDE ES METOTREXATO

N473 (Thu Mar 12): LA GOTA ES UNA ARTRITIS POR DEPOSITO DE CRISTALES DE URATO MONOSODICO

N474 (Thu Mar 12): LA ARTICULACION MAS AFECTADA EN GOTA ES LA PRIMERA METATARSOFALANGICA (PODOGRA)

N475 (Thu Mar 12): EL GOLD STANDARD PARA DIAGNOSTICO DE GOTA ES LA IDENTIFICACION DE CRISTALES DE URATO EN LIQUIDO SINOVIAL

N476 (Fri Mar 13): EL TRATAMIENTO DEL ATAQUE AGUDO DE GOTA ES AINE O COLCHICINA

N477 (Fri Mar 13): EL TRATAMIENTO CRONICO DE GOTA ES ALOPURINOL O FEBUXOSTAT

N478 (Fri Mar 13): LA PSEUDOGOTA ES PRODUCIDA POR CRISTALES DE PIROFOSFATO DE CALCIO

N479 (Fri Mar 13): LA ARTICULACION MAS AFECTADA EN PSEUDOGOTA ES LA RODILLA

N480 (Fri Mar 13): LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE SE ASOCIA AL HLA-B27

N481 (Fri Mar 13): LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE AFECTA PRINCIPALMENTE ARTICULACIONES SACROILIACAS #ENAR

N482 (Fri Mar 13): EL DOLOR EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE ES INFLAMATORIO, MEJORA CON EJERCICIO Y EMPEORA CON REPOSO

N483 (Fri Mar 13): EL HALLAZGO RADIOLOGICO CARACTERISTICO DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE ES COLUMNA EN CAÑA DE BAMBU

N484 (Fri Mar 13): EL TRATAMIENTO INICIAL DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE SON AINES

N485 (Fri Mar 13): LA ARTRITIS REACTIVA SE ASOCIA A INFECCIONES POR CHLAMYDIA, SALMONELLA, SHIGELLA Y YERSINIA

N486 (Mon Mar 16): LA TRIADA CLASICA DE ARTRITIS REACTIVA ES ARTRITIS, URETRITIS Y CONJUNTIVITIS

N487 (Mon Mar 16): LA ARTRITIS PSORIASICA SE ASOCIA A LESIONES CUTANEAS DE PSORIASIS

N488 (Mon Mar 16): EL DACTILITIS O ?DEDOS EN SALCHICHA? ES CARACTERISTICO DE ARTRITIS PSORIASICA

N489 (Mon Mar 16): LA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ES UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE MULTISISTEMICA

N490 (Mon Mar 16): EL ANTICUERPO MAS SENSIBLE PARA LUPUS ES EL ANA

N491 (Mon Mar 16): EL ANTICUERPO MAS ESPECIFICO PARA LUPUS ES EL ANTI-DNA DE DOBLE CADENA

N492 (Mon Mar 16): LA DISMINUCION DE COMPLEMENTO C3 Y C4 SUGIERE ACTIVIDAD DE LUPUS

N493 (Mon Mar 16): EL SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO SE ASOCIA A TROMBOSIS Y PERDIDAS GESTACIONALES

N494 (Mon Mar 16): LOS ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA Y ANTICOAGULANTE LUPICO SON CARACTERISTICOS DE SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO

N495 (Mon Mar 16): LA ESCLERODERMIA SE CARACTERIZA POR FIBROSIS CUTANEA Y DE ORGANOS INTERNOS

N496 (Tue Mar 17): EL FENOMENO DE RAYNAUD ES UNA MANIFESTACION TEMPRANA DE ESCLERODERMIA

N497 (Tue Mar 17): EL ANTICUERPO ANTICENTROMERO SE ASOCIA A ESCLERODERMIA LIMITADA

N498 (Tue Mar 17): EL ANTICUERPO ANTI-SCL70 SE ASOCIA A ESCLERODERMIA DIFUSA

N499 (Tue Mar 17): LA POLIMIOSITIS Y DERMATOMIOSITIS SON MIOPATIAS INFLAMATORIAS

N500 (Tue Mar 17): LA DEBILIDAD MUSCULAR PROXIMAL SIMETRICA ES CARACTERISTICA DE POLIMIOSITIS

N501 (Tue Mar 17): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE DIARREA AGUDA EN ADULTOS ES VIRAL (NOROVIRUS)

N503 (Tue Mar 17): LA DIARREA POR VIBRIO CHOLERAES ES ACUOSA TIPO ?AGUA DE ARROZ?

N506 (Wed Mar 18): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE DIARREA ASOCIADA A ANTIBIOTICOS ES CLOSTRIDIODES DIFFICILE

N516 (Thu Mar 19): LA PANCREATITIS AGUDA SE DIAGNOSTICA CON 2 DE 3: DOLOR TIPICO, AMILASA/LIPASA ELEVADA, IMAGEN COMPATIBLE

N520 (Thu Mar 19): LA PRINCIPAL CAUSA DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO SON LAS ULCERAS PEPTICAS

N521 (Thu Mar 19): LA SEGUNDA CAUSA DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO SON LAS VARICES ESOFAGICAS

N525 (Thu Mar 19): LA CIRROSIS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE HIPERTENSION PORTAL

N526 (Fri Mar 20): LAS COMPLICACIONES DE CIRROSIS INCLUYEN ASCITIS, VARICES, ENCEFALOPATIA Y SINDROME HEPATORRENAL

N527 (Fri Mar 20): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE CIRROSIS ES ALCOHOLISMO

N528 (Fri Mar 20): EL LIQUIDO DE ASCITIS CON GRADIENTE ALBUMINA SUERO-ASCITIS >1.1 SUGIERE HIPERTENSION PORTAL

N529 (Fri Mar 20): EL TRATAMIENTO DE ASCITIS ES RESTRICCION DE SODIO Y DIURETICOS (ESPIRONOLACTONA)

N530 (Fri Mar 20): LA ENCEFALOPATIA HEPATICA SE MANEJA CON LACTULOSA

N531 (Sat Mar 21): LA HEPATITIS A SE TRANSMITE VIA FECAL-ORAL

N532 (Sat Mar 21): LA HEPATITIS B SE TRANSMITE POR VIA PARENTERAL, SEXUAL Y PERINATAL

N533 (Sat Mar 21): EL ANTIGENO HBSAG POSITIVO INDICA INFECCION ACTIVA POR HEPATITIS B

N534 (Sat Mar 21): EL ANTICUERPO ANTI-HBS INDICA INMUNIDAD CONTRA HEPATITIS B

N535 (Sat Mar 21): LA HEPATITIS C SE TRANSMITE PRINCIPALMENTE POR VIA PARENTERAL

N540 (Mon Mar 23): LA SEPSIS SE DEFINE COMO DISFUNCION ORGANICA SECUNDARIA A RESPUESTA DESREGULADA A INFECCION

N544 (Wed Mar 25): LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD ES CAUSADA PRINCIPALMENTE POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

N545 (Wed Mar 25): EL ESTUDIO DE ELECCION PARA NEUMONIA ES RADIOGRAFIA DE TORAX

N546 (Thu Mar 26): EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NEUMONIA ES AMOXICILINA O MACROLIDO

N547 (Thu Mar 26): LA ESCALA CURB-65 SE UTILIZA PARA EVALUAR GRAVEDAD DE NEUMONIA

N548 (Thu Mar 26): EL EPOC SE ASOCIA PRINCIPALMENTE AL TABAQUISMO

N549 (Thu Mar 26): EL GOLD ESTANDAR DIAGNOSTICO DE EPOC ES ESPIROMETRIA

N550 (Thu Mar 26): EL CRITERIO DIAGNOSTICO DE EPOC ES FEV1/FVC <70% POSTBRONCODILATADOR

N551 (Thu Mar 26): EL TRATAMIENTO BASE DE EPOC SON BRONCODILATADORES DE LARGA DURACION

N552 (Thu Mar 26): EL ASMA ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRONICA DE LA VIA AEREA

N553 (Thu Mar 26): EL DIAGNOSTICO DE ASMA SE CONFIRMA CON ESPIROMETRIA REVERSIBLE

N554 (Thu Mar 26): EL TRATAMIENTO DE RESCATE EN ASMA SON BETA-2 AGONISTAS DE ACCION CORTA

N555 (Thu Mar 26): EL TRATAMIENTO CONTROLADOR DE ASMA SON ESTEROIDES INHALADOS

N557 (Fri Mar 27): LA TUBERCULOSIS PULMONAR SE MANIFIESTA CON TOS CRONICA, FIEBRE Y SUDORACION NOCTURNA

N558 (Fri Mar 27): EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS SE CONFIRMA CON BACILOSCOPIA O GENEXPERT

N559 (Fri Mar 27): EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS ES ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA Y ETAMBUTOL

N560 (Fri Mar 27): LA FASE INTENSIVA DE TUBERCULOSIS DURA 2 MESES

N561 (Fri Mar 27): EL VIH SE TRANSMITE POR VIA SEXUAL, SANGUINEA Y PERINATAL

N562 (Fri Mar 27): EL VIRUS VIH INFECTA PRINCIPALMENTE LINFOCITOS CD4

N563 (Fri Mar 27): EL DIAGNOSTICO DE VIH SE REALIZA CON PRUEBAS SEROLOGICAS (ELISA Y CONFIRMACION)

N564 (Fri Mar 27): EL CRITERIO DE SIDA ES CD4 <200 CELULAS/ μ L O INFECCION OPORTUNISTA

N565 (Fri Mar 27): LA INFECCION OPORTUNISTA MAS FRECUENTE EN VIH ES NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI

N566 (Fri Mar 27): EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA PARA PCP ES TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL

N567 (Fri Mar 27): LA PROFILAXIS PARA PCP SE INICIA CUANDO CD4 <200 CELULAS/ μ L

N568 (Fri Mar 27): LA SIFILIS ES CAUSADA POR TREPONEMA PALLIDUM

N569 (Fri Mar 27): LA LESION PRIMARIA DE SIFILIS ES EL CHANCRO INDOLORO

N570 (Fri Mar 27): EL TRATAMIENTO DE SIFILIS ES PENICILINA G BENZATINICA

N571 (Mon Mar 30): LA GONORREA ES CAUSADA POR NEISSERIA GONORRHOEAE

N572 (Mon Mar 30): EL TRATAMIENTO DE GONORREA ES CEFTRIAXONA

N573 (Mon Mar 30): LA CLAMIDIA ES CAUSADA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS

N574 (Mon Mar 30): EL TRATAMIENTO DE CLAMIDIA ES AZITROMICINA O DOXICICLINA

N575 (Mon Mar 30): LA INFECCION URINARIA MAS FRECUENTE ES POR ESCHERICHIA COLI

N576 (Tue Mar 31): EL DIAGNOSTICO DE IVU SE REALIZA CON EXAMEN GENERAL DE ORINA Y UROCULTIVO

N577 (Tue Mar 31): EL TRATAMIENTO DE CISTITIS NO COMPLICADA ES NITROFURANTOINA O FOSFOMICINA

N578 (Tue Mar 31): LA PIELONEFRITIS SE MANIFIESTA CON FIEBRE, DOLOR LUMBAR Y SINTOMAS URINARIOS

N579 (Tue Mar 31): EL TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS ES ANTIBIOTICO SISTEMICO

N580 (Tue Mar 31): LA BACTERIURIA ASINTOMATICA SOLO SE TRATA EN EMBARAZO Y PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS

N653 (Wed Apr 15): LA HIPERNATREMIA SE DEFINE COMO NA >145 MEQ/L

N654 (Wed Apr 15): LA HIPOCALEMIA SE DEFINE COMO K <3.5 MEQ/L

N655 (Wed Apr 15): LA HIPERCALEMIA SE DEFINE COMO K >5.5 MEQ/L

N660 (Thu Apr 16): LA RESINA DE INTERCAMBIO (KAYEXALATE) ELIMINA POTASIO

N701 (Mon Apr 27): EL SINDROME CORONARIO AGUDO SE CLASIFICA EN IAM CON ELEVACION DEL ST, SIN ELEVACION DEL ST Y ANGINA INESTABLE

N703 (Mon Apr 27): EL BIOMARCADOR MAS ESPECIFICO PARA INFARTO ES LA TROPONINA

N704 (Mon Apr 27): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL SCA INCLUYE MONA: MORFINA, OXIGENO, NITRATOS Y ASPIRINA

N705 (Mon Apr 27): EL TRATAMIENTO DE ELECCION EN IAM CON ELEVACION DEL ST ES LA REPERFUSION CON ANGIOPLASTIA

N707 (Tue Apr 28): LA PRINCIPAL COMPLICACION TEMPRANA DEL IAM SON LAS ARRITMIAS

N708 (Tue Apr 28): LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN IAM ES FIBRILACION VENTRICULAR

N709 (Tue Apr 28): LA INSUFICIENCIA CARDIACA SE DEFINE COMO INCAPACIDAD DEL CORAZON PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL ORGANISMO

N710 (Tue Apr 28): EL SINTOMA MAS FRECUENTE DE INSUFICIENCIA CARDIACA ES DISNEA

N711 (Wed Apr 29): EL TRATAMIENTO DE BASE EN IC INCLUYE IECA, BETABLOQUEADOR Y DIURETICO

N712 (Wed Apr 29): EL PEPTIDO BNP SE ELEVA EN INSUFICIENCIA CARDIACA

N713 (Wed Apr 29): LA FIBRILACION AURICULAR ES LA ARRITMIA MAS FRECUENTE

N714 (Wed Apr 29): EL RIESGO DE FA ES EVENTO EMBOLICO CEREBRAL

N715 (Wed Apr 29): EL MANEJO DE FA INCLUYE CONTROL DE FRECUENCIA Y ANTICOAGULACION

N716 (Wed Apr 29): EL CHADSVASC SE UTILIZA PARA EVALUAR RIESGO DE EVC EN FA

N718 (Wed Apr 29): LA ADENOSINA ES FARMACO DE ELECCION EN TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR

N720 (Wed Apr 29): EL BLOQUEO AV COMPLETO REQUIERE MARCAPASOS

N721 (Thu Apr 30): LA DIABETES MELLITUS SE DIAGNOSTICA CON GLUCOSA EN AYUNO ≥ 126 MG/DL

N722 (Thu Apr 30): LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA $\geq 6.5\%$ ES CRITERIO DIAGNOSTICO DE DIABETES

N723 (Thu Apr 30): LOS SINTOMAS CLASICOS DE DIABETES SON POLIURIA, POLIDIPSIA Y POLIFAGIA

N724 (Thu Apr 30): LA CETOACIDOSIS DIABETICA SE CARACTERIZA POR HIPERGLUCEMIA, ACIDOSIS METABOLICA Y CETONEMIA

N725 (Thu Apr 30): EL TRATAMIENTO DE CETOACIDOSIS INCLUYE LIQUIDOS, INSULINA Y CORRECCION DE ELECTROLITOS

N728 (Mon May 04): LA HIPOGLUCEMIA SE DEFINE COMO GLUCOSA < 70 MG/DL

N730 (Mon May 04): LA TIROIDITIS DE HASHIMOTO ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE HIPOTIROIDISMO

N731 (Mon May 04): EL HIPOTIROIDISMO SE MANIFIESTA CON AUMENTO DE PESO, BRADICARDIA Y INTOLERANCIA AL FRIO

N732 (Mon May 04): EL TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO ES LEVOTIROXINA

N733 (Mon May 04): LA ENFERMEDAD DE GRAVES ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE HIPERTIROIDISMO

N734 (Mon May 04): EL HIPERTIROIDISMO SE MANIFIESTA CON PERDIDA DE PESO, TAQUICARDIA Y INTOLERANCIA AL CALOR

N735 (Mon May 04): EL TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO INCLUYE METIMAZOL Y PROPRANOLOL

N737 (Tue May 05): EL TRATAMIENTO DE TORMENTA TIROIDEA INCLUYE BETABLOQUEADOR, ANTITIROIDEOS Y YODO

N738 (Tue May 05): EL HIPERPARATIROIDISMO CAUSA HIPERCALCEMIA

N739 (Tue May 05): EL HIPOPARATIROIDISMO CAUSA HIPOCALCEMIA

N740 (Tue May 05): LA HIPERCALCEMIA SE MANIFIESTA CON ?STONES, BONES, GROANS AND PSYCHIATRIC OVERSTONES?

N741 (Wed May 06): EL EVENTO VASCULAR CEREBRAL SE CLASIFICA EN ISQUEMICO Y HEMORRAGICO

N743 (Wed May 06): EL FACTOR DE RIESGO MAS IMPORTANTE PARA EVC ES HIPERTENSION ARTERIAL

N744 (Wed May 06): EL ESTUDIO INICIAL EN SOSPECHA DE EVC ES TAC DE CRANEO SIN CONTRASTE

N745 (Wed May 06): EL TRATAMIENTO DEL EVC ISQUEMICO AGUDO ES TROMBOLISIS CON ALTEPLASA EN LAS PRIMERAS 4.5 HORAS

N748 (Thu May 07): LA CRISIS EPILEPTICA GENERALIZADA TONICO-CLONICA ES LA MAS FRECUENTE

N751 (Fri May 08): LA MENINGITIS BACTERIANA SE MANIFIESTA CON FIEBRE, RIGIDEZ DE NUCA Y ALTERACION DEL ESTADO MENTAL

N753 (Fri May 08): EL ESTUDIO DIAGNOSTICO DE MENINGITIS ES PUNCION LUMBAR

N754 (Fri May 08): EL TRATAMIENTO EMPIRICO DE MENINGITIS ES ANTIBIOTICOS DE AMPLIO ESPECTRO

N755 (Fri May 08): LA ENCEFALITIS MAS FRECUENTE ES POR VIRUS HERPES SIMPLE

N757 (Mon May 11): LA MIGRAÑA ES UNA CEFALEA PULSATIL UNILATERAL CON NAUSEA Y FOTOFONOFIA

N758 (Mon May 11): EL TRATAMIENTO AGUDO DE MIGRAÑA ES AINES O TRIPTANOS

N759 (Mon May 11): LA CEFALEA EN RACIMOS SE CARACTERIZA POR DOLOR INTENSO PERIORBITARIO

N760 (Mon May 11): EL TRATAMIENTO DE CEFALEA EN RACIMOS ES OXIGENO Y SUMATRIPTAN

N761 (Tue May 12): LA LESION RENAL AGUDA SE DEFINE POR AUMENTO DE CREATININA O DISMINUCION DE DIURESIS

N763 (Tue May 12): LA NECROSIS TUBULAR AGUDA ES LA CAUSA MAS FRECUENTE DE IRA INTRINSECA

N764 (Tue May 12): LA HIPERKALEMIA ES LA ALTERACION ELECTROLITICA MAS GRAVE EN IRA

N765 (Tue May 12): LAS INDICACIONES DE DIALISIS SE RESUMEN EN AEIOU

N767 (Wed May 13): LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA SE DEFINE COMO DAÑO RENAL >3 MESES

N768 (Wed May 13): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA ES DIABETES MELLITUS

N769 (Wed May 13): LA HIPERTENSION ES LA SEGUNDA CAUSA DE ERC

N770 (Wed May 13): LA TASA DE FILTRACION GLOMERULAR SE UTILIZA PARA ESTADIFICAR ERC

N771 (Thu May 14): EL SINDROME NEFROTICO SE CARACTERIZA POR PROTEINURIA >3.5 G/DIA, HIPOALBUMINEMIA Y EDEMA

N773 (Thu May 14): EL SINDROME NEFRITICO SE CARACTERIZA POR HEMATURIA, HTA Y EDEMA

N774 (Thu May 14): LA GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCOCICA OCURRE DESPUES DE INFECCION FARINGEA O CUTANEA

N776 (Fri May 15): LA PIELONEFRITIS AGUDA SE MANIFIESTA CON FIEBRE, DOLOR EN ANGULO COSTOVERTEBRAL Y PIURIA

N777 (Fri May 15): EL UROCULTIVO ES EL GOLD ESTANDAR PARA DIAGNOSTICO DE IVU

N781 (Tue May 19): LA ANEMIA MAS FRECUENTE A NIVEL MUNDIAL ES LA FERROPENICA

N782 (Tue May 19): LA PRINCIPAL CAUSA DE ANEMIA FERROPENICA EN ADULTOS ES SANGRADO CRONICO

N783 (Tue May 19): LA ANEMIA FERROPENICA SE CARACTERIZA POR MICROCITOSIS E HIPOCROMIA

N784 (Tue May 19): LA FERRITINA ES EL MEJOR MARCADOR DE RESERVAS DE HIERRO

N785 (Tue May 19): EL TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPENICA ES HIERRO ORAL

N786 (Wed May 20): LA ANEMIA MEGALOBLASTICA ES CAUSADA POR DEFICIENCIA DE B12 O FOLATO

N787 (Wed May 20): LA DEFICIENCIA DE B12 PUEDE CAUSAR ALTERACIONES NEUROLOGICAS

N788 (Wed May 20): LA ANEMIA APLASICA SE CARACTERIZA POR PANCITOPENIA

N789 (Wed May 20): LA ANEMIA HEMOLITICA PRESENTA DHL ELEVADA Y HAPTOGLOBINA BAJA

N790 (Wed May 20): LA ESFEROCITOSIS HEREDITARIA PRESENTA ESFEROCITOS EN FROTIS

N792 (Fri May 22): LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA ES MAS FRECUENTE EN ADULTOS

N793 (Fri May 22): LOS BASTONES DE AUER SON CARACTERISTICOS DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

N794 (Fri May 22): LA TRANSLOCACION T(15;17) SE ASOCIA A LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA

N795 (Fri May 22): EL TRATAMIENTO DE LEUCEMIA PROMIELOCITICA INCLUYE ATRA

N796 (Fri May 22): EL LINFOMA DE HODGKIN SE CARACTERIZA POR CELULAS DE REED-STERBERG

N797 (Fri May 22): EL GANGLIO CERVICAL ES EL SITIO MAS FRECUENTE EN LINFOMA DE HODGKIN

N798 (Fri May 22): LOS SINTOMAS B SON FIEBRE, SUDORACION NOCTURNA Y PERDIDA DE PESO

N800 (Fri May 22): EL TRATAMIENTO INICIAL DE NEUTROPENIA FEBRIL ES ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO

N841 (Wed Jun 03): EL SÍNDROME DE MALLORY-WEISS CONSISTE EN DESGARROS LONGITUDINALES EN ESÓFAGO DISTAL Y ESTÓMAGO PROXIMAL SECUNDARIOS A AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL

N843 (Wed Jun 03): LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE SÍNDROME DE MALLORY-WEISS EN MUJERES ES LA HIPERÉMESIS GRAVÍDICA

N846 (Thu Jun 04): LA PROTEÍNA PATÓGENA MÁS IMPORTANTE DE HELICOBACTER PYLORI ES CAGA

N847 (Thu Jun 04): EL ESTUDIO INICIAL DE ELECCIÓN PARA HELICOBACTER PYLORI ES LA PRUEBA DE ALIENTO CON UREA MARCADA CON CARBONO 13

N848 (Thu Jun 04): LAS COMPLICACIONES CLÁSICAS DE HELICOBACTER PYLORI SON GASTRITIS CRÓNICA TIPO B, ÚLCERA PÉPTICA, LINFOMA MALT Y ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

N849 (Thu Jun 04): EL TRATAMIENTO TRIPLE CLÁSICO PARA ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI ES AMOXICILINA MÁS CLARITROMICINA MÁS IBP DURANTE 14 DÍAS

N850 (Thu Jun 04): PARA SER CONSIDERADA ÚLCERA PÉPTICA DEBE PENETRAR MÁS ALLÁ DE LA MUSCULAR DE LA MUCOSA

N851 (Fri Jun 05): LA PRINCIPAL CAUSA DE ÚLCERA PÉPTICA ES HELICOBACTER PYLORI

N853 (Fri Jun 05): LA PRINCIPAL CAUSA DE REFRACTARIEDAD DE UNA ÚLCERA PÉPTICA ES EL TABAQUISMO

N854 (Fri Jun 05): LOS INHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES DEBEN ADMINISTRARSE 30 MINUTOS ANTES DE LOS ALIMENTOS

N856 (Mon Jun 08): LAS ÚLCERAS GÁSTRICAS CON MAYOR FRECUENCIA DE SANGRADO SON LAS PREPILÓRICAS

N857 (Mon Jun 08): LA ÚLCERA DUODENAL SUELE LOCALIZARSE EN LA PRIMERA PORCIÓN DEL DUODENO

N858 (Mon Jun 08): EL DOLOR DE LA ÚLCERA DUODENAL APARECE DOS HORAS DESPUÉS DE COMER Y MEJORA CON ALIMENTOS O ANTIÁCIDOS

N860 (Mon Jun 08): LA ESCALA DE ROCKALL PREDICE MORTALIDAD Y NECESIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN SANGRADO POR ÚLCERA PÉPTICA

N861 (Mon Jun 08): LA ESCALA DE BLATCHFORD AYUDA A DECIDIR INTERVENCIÓN ENDOSCÓPICA TEMPRANA

N868 (Tue Jun 09): EL ESTUDIO INICIAL PARA SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON ES GASTRINA SÉRICA EN AYUNO MÁS MEDICIÓN DE PH GÁSTRICO

N869 (Tue Jun 09): EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ZOLLINGER-ELLISON ES OMEPRAZOL EN DOSIS ALTAS

N870 (Tue Jun 09): EL SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON SE ASOCIA A NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1

N871 (Wed Jun 10): LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON ES LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON SECRETINA

N873 (Wed Jun 10): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA DIAGNÓSTICO DE ACALASIA ES LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA

N876 (Wed Jun 10): EL ESÓFAGO DE BARRETT ES LA METAPLASIA DEL EPITELIO ESCAMOSO ESOFÁGICO A EPITELIO COLUMNAR INTESTINAL

N878 (Wed Jun 10): EL ESÓFAGO DE BARRETT AUMENTA EL RIESGO DE ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO

N879 (Wed Jun 10): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA DIAGNÓSTICO DE ESÓFAGO DE BARRETT ES ENDOSCOPIA CON BIOPSIA

N880 (Wed Jun 10): EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA ERGE CONSISTE EN MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA E IBP

N881 (Fri Jun 12): LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON ES LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON SECRETINA

N883 (Fri Jun 12): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACALASIA ES LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA

N886 (Mon Jun 15): EL ESÓFAGO DE BARRETT ES LA METAPLASIA DEL EPITELIO ESCAMOSO ESOFÁGICO A EPITELIO COLUMNAR INTESTINAL

N888 (Mon Jun 15): EL ESÓFAGO DE BARRETT AUMENTA EL RIESGO DE ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO

N889 (Mon Jun 15): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESÓFAGO DE BARRETT ES LA ENDOSCOPIA CON BIOPSIA

N890 (Mon Jun 15): EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA ERGE CONSISTE EN MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA E IBP

N899 (Thu Jun 18): LA DISENTERÍA SE CARACTERIZA POR DIARREA CON SANGRE Y MOCO

N900 (Thu Jun 18): LA PRINCIPAL INDICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN DIARREA AGUDA ES LA SOSPECHA DE INFECCIÓN BACTERIANA INVASIVA

N934 (Tue Jun 30): EL VIH PUEDE TRANSMITIRSE DE MADRE A HIJO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O LACTANCIA

N964 (Wed Jul 08): LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN TIENEN MAYOR RIESGO DE COLELITIASIS

N970 (Thu Jul 09): EN PACIENTES CON SIDA PUEDEN PRESENTARSE CASOS DE COLANGITIS POR CITOMEGALOVIRUS O CRIPTOSPORIDIOS

N986 (Wed Jul 15): EL PATRÓN COLESTÁSICO SE CARACTERIZA POR HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA, ICTERICIA Y COLURIA

N996 (Fri Jul 17): LOS ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES POSITIVOS SON CARACTERÍSTICOS DE LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA

N997 (Fri Jul 17): LA BIOPSIA HEPÁTICA ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE COLANGITIS BILIAR PRIMARIA

N1023 (Fri Jul 24): EL SIGNO DE GRAY-TURNER CONSISTE EN EQUIMOSIS EN LOS FLANCOS

N1026 (Mon Jul 27): LA HIPERTRIGLICERIDEMIA PUEDE CAUSAR PANCREATITIS AGUDA CUANDO LOS TRIGLICÉRIDOS SON MAYORES DE 1000 MG/DL

N1033 (Tue Jul 28): LA TOMOGRAFÍA ABDOMINAL CON CONTRASTE ES EL ESTÁNDAR DE ORO DE IMAGEN EN PANCREATITIS AGUDA

N1036 (Wed Jul 29): LA ALIMENTACIÓN EN PANCREATITIS AGUDA DEBE INICIARSE DURANTE LAS PRIMERAS 24 A 48 HORAS SI EL PACIENTE ESTÁ ESTABLE

N1043 (Thu Jul 30): UNA LIPASA O AMILASA MAYOR DE TRES VECES EL LÍMITE SUPERIOR NORMAL APOYA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS AGUDA

N1046 (Fri Jul 31): UNA ALANINA AMINOTRANSFERASA MAYOR DE 150 UI/L SUGIERE ETIOLOGÍA BILIAR EN PANCREATITIS AGUDA

N1053 (Mon Aug 03): LA SOLUCIÓN DE RINGER LACTATO ES EL CRISTALOIDE PREFERIDO PARA LA REANIMACIÓN INICIAL EN PANCREATITIS AGUDA

N1056 (Wed Aug 05): EN PANCREATITIS AGUDA GRAVE SE PREFIERE LA NUTRICIÓN ENTERAL SOBRE LA NUTRICIÓN PARENTERAL

N1063 (Thu Aug 06): LA TRÍADA CLÁSICA DE PANCREATITIS CRÓNICA ES CALCIFICACIONES PANCREÁTICAS, ESTEATORREA Y DIABETES

N1066 (Fri Aug 07): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS CRÓNICA ES LA CPRE

N1083 (Wed Aug 12): LAS PRUEBAS GENÉTICAS PARA SÍNDROME DE LYNCH SE SOLICITAN CUANDO SE CUMPLEN LOS CRITERIOS CLÍNICOS DE ÁMSTERDAM

N1104 (Thu Aug 20): LA TUBERCULOSIS GENITOURINARIA ES EL SEGUNDO SITIO DE INFECCIÓN EXTRAPULMONAR POR TUBERCULOSIS

N1105 (Thu Aug 20): LA TRÍADA DE COLOMBINO EN TUBERCULOSIS GENITOURINARIA CONSISTE EN ORINA ÁCIDA, PIURIA Y ORINA ASÉPTICA

N1106 (Fri Aug 21): EL CULTIVO DE LÖWENSTEIN ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN SEÑALADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS GENITOURINARIA

N1115 (Fri Aug 21): EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE PRIMERA ELECCIÓN DEL ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO CONSISTE EN BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO O NITRATOS SUBLINGUALES

N1117 (Fri Aug 21): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ERGE ES LA PHMETRÍA CON IMPEDANCIA DE 24 HORAS

N1127 (Thu Aug 27): LA DIVERTICULOSIS CONSISTE EN LA PRESENCIA DE DIVERTÍCULOS EN UN PACIENTE ASINTOMÁTICO

N1137 (Mon Aug 31): LOS DOS SÍNTOMAS MÁS REPORTADOS EN HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA SON NICTURIA Y DISMINUCIÓN DEL CHORRO URINARIO